

■ 嚥下／理学療法

嚥下理学療法の コンセンサスブック公開

日本栄養・嚥下理学療法学会 21の臨床疑問に回答、エビデンスレベルは付けず

日本栄養・嚥下理学療法学会が、学会誌の総説として「嚥下理学療法コンセンサスブック」を公開した(鈴木裕也氏ら)。PDFは学会サイトで無料で読める。呼吸・姿勢・体幹・全身機能・身体活動・認知機能・多職種連携・集中治療などの領域で、臨床でよく出会う21の疑問(CQ)に「回答＋解説」で答える。

委員が挙げた153のCQを3回のデルファイ法で84

に絞り、会議と理事会の意見で21に統合した。2024年までの論文をPubMed・医中誌で系統的に探し、理事・評議員のパブリックコメントと外部委員5人の査読を経た。嚥下理学療法の定義や実践がまだ普及途上で質の高い証拠を集めにくいとして、エビデンスレベルのランク付けはしていない。

例えば挿管中の唾液誤嚥の予防はベッドアップ

30～45度が基本で水平仰臥位は避ける、座位が難しい食事は30度以上のセミファーラー位、回復期脳卒中で椅子立ち上がりを1日36回以上行った群で嚥下が改善、1日4時間以上の離床が嚥下機能の維持に要る可能性、などが並ぶ。数字は元の研究の条件付きで、ガイドラインではなく、現時点の到達点と未解明の所を示す資料だ。



姿勢と離床から、飲み込みを支える

出典 **日本栄養・嚥下理学療法学会雑誌** ↗

数字で見る

21問

回答した臨床疑問(CQ)

153問

最初に挙げた候補

4時間

嚥下維持に要る離床(1日)

■ 脳卒中／急性期リハ

早期リハ、1日60分・初日開始で有害事象が最少

入院2日以内にリハを始めた脳卒中患者で、1日20～60分・入院1日目か2日目開始の6方式を14日目まで続けたと仮定し、15日以内の複合有害事象を比べた。基準の方式は11.2%、最多の方式は26.2%(リスク比2.35)、最少は0.49%(同0.04)。

量が多いほど有害事象は少なく、1日60分・初日開始が最も低いと推定された。ただし中間の量



は条件で結果が揺れた。観察データで重症者ほど量が少ない偏りは残りうる。著者は適切な患者選択と監視を前提にと結ぶ。

出典 **Neurorehabil Neural Repair** ↗

■ 転倒予防／服薬

膝OAの転倒、鎮痛系の薬と体力低下が別々に増やす

米国のOsteoarthritis Initiativeの参加者で、開始時にオピオイドか抗うつ薬を使っていた人は、転倒のオッズが1.16倍、2回以上の反復転倒が1.30倍(95%CI 1.18～1.42)だった。400m歩行が遅い、椅子の繰り返し立ち上がりができないことも、それぞれ独立に転倒と関連した。

薬と体力の間に交互作用はなかった。観察研究



で、薬を減らせば転倒が減るかは示していない。処方が変わった時に立ち上がりや歩行を測り直すことが、転倒予防の具体的な入口になる。

出典 **Arch Phys Med Rehabil** ↗

短 信

〈脳卒中〉歩行の集中練習、1日3時間でも出席9割

HiWalk試験に併設の研究。3週間の高用量歩行練習で出席率91%、1時間に平均567歩を反復 出典 **Disabil Rehabil** ↗

〈心臓リハ〉心臓への不安、心疾患患者の最大5割

26研究・9,628人の系統的レビュー。高い心臓不安は15～49%で、心筋梗塞後の心事故・死亡と関連した

出典 **Eur J Prev Cardiol** ↗

〈呼吸リハ〉喉頭摘出後の人工鼻、24時間使用で咳が減少

ブラジルの79人のRCT。1日23時間超使い、9か月で強制的な喀痰が対照の半分に 出典 **Laryngoscope Investig Otolaryngol** ↗

〈制度〉リハ職の予算、文科省やスポーツ庁にも

令和9年度概算要求。特別支援教育でPT・OT・STら外部専門家の活用に1.95億円 出典 **PT-OT-ST.NET** ↗

〈フレイル〉血中NAD+が低い高齢者、フレイル多く

東京都健康長寿医療センターの65歳以上529人。NAD+が1μmol/L高いごとにフレイルのオッズ約13%低い(横断研究) 出典 **GemMed** ↗

〈外傷性脳損傷〉TBI後の社会参加、環境と偏見が左右

質的研究28件の統合。制度の壁、周囲のスティグマ、文化的な語りが参加の満足度を左右していた 出典 **Disabil Rehabil** ↗

〈心臓リハ〉心疾患の性リハ、心リハへの統合は不十分

29文献のスコーピングレビュー。教育・相談が中心で、担い手は看護師や多職種 出典 **Patient Prefer Adherence** ↗

〈在宅医療〉米退役軍人省の在宅入院、体制は施設差大

6プログラムの比較。看護師4～7人・医師1～2人の常勤換算で、年間63～146人を自宅で入院治療していた

出典 **J Am Geriatr Soc** ↗